

유방암 진단 첫 30일

아형 · 수술 · 전신치료 순서 이해

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 01

완전판 · 2026년 10월 개정 2판

유방암은 하나의 병이 아닙니다. 호르몬수용체와 HER2가 치료 순서를 바꿉니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Breast Cancer, Version 7.2026(환자용 해설 2.2026-0기 1.2026 대조) 외 국내 자료(본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 책의 사용법

이 책은 처음부터 끝까지 읽는 책이 아닙니다. **지금 내 상황에 필요한 장만 펴서 쓰는 책**입니다.

지금 내 상황	먼저 펼 곳
방금 진단을 들었고 머리가 하얗다	1장 「먼저 구분하세요」 → 「진단 뒤 72시간」
몸에 이상 신호가 있다	「기다리지 않는 신호」 (응급 상자)
다음 주에 진료가 잡혀 있다	해당 치료 장 + 워크북 「진료 기록지」
검사 결과지를 받았다	PART 1의 병리·검사·병기 장
돈·보험·회사가 걱정이다	PART 5 「돈 · 서류 · 제도」
마음이 무너질 것 같다	PART 4 「마음 돌보기」
가족으로서 무엇을 해야 할지 모르겠다	PART 4 「보호자에게」

각 장의 구성은 같습니다.

- **30초 요약** — 바쁠 때는 이 상자만 읽어도 됩니다.
- **본문** — 왜 그런지, 무엇을 확인하는지.
- **오늘 물어볼 질문** — 진료실에 가져갈 질문은 장마다 3개 이내로 골랐습니다.
- **기록칸** — 들은 내용을 그 자리에서 적습니다. 보호자가 적어도 좋습니다.
- **🆘 응급 상자** — 기다리지 말고 연락해야 하는 신호입니다.

이 책의 표시:  확정된 정보 ·  검사·결정 대기 ·  아직 모름/확인 필요.
색이 아니라 기호로 구분했으니 흑백으로 인쇄해도 그대로 쓸 수 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 0기와 침윤암, 그리고 아형

30초 요약

- **0기(관상피내암, DCIS)**는 암세포가 젖관 안에 머문 **비침윤성** 암입니다. 침윤암과 치료 범위가 다릅니다(4장).
- **침윤성 유방암**은 아형이 치료 순서를 정합니다: **호르몬수용체(ER·PR) · HER2 · 등급/Ki-67 · 병기**.
- 같은 "2기"라도 아형에 따라 **수술 먼저** 또는 **약물치료 먼저**가 될 수 있습니다.

결과지에 적힌 말	뜻	볼 곳
DCIS, 관상피내암, 유방 상피내암	0기, 비침윤성	4장
LCIS, 소엽상피내종양	대개 암이 아니라 위험 표지 . 치료가 아니라 추적·위험 관리	담당의 확인
침윤성 유관암(IDC, NST)	가장 흔한 침윤성 유방암	이 책 전체
침윤성 소엽암(ILC)	두 번째로 흔함. 영상에서 범위가 작게 보일 수 있어 MRI를 더하기도 함	5장

아형 4가지 한눈에 보기

아형	검사 결과	치료의 큰 축
HR+/HER2- (가장 흔함)	ER 또는 PR 양성, HER2 음성	수술 → (필요 시 항암) → 내분비요법 5~10년

아형	검사 결과	치료의 큰 축
HER2 양성(유방암의 약 15~20%)	HER2 3+ 또는 2+·ISH 양성	항암 + HER2 표적치료. 종양이 크거나 림프절 양성이면 수술 전 치료
삼중음성	ER·PR·HER2 모두 음성	항암 중심, 2기 이상은 수술 전 항암 (+면역치료 범주)
HR+/HER2+ (삼중양성)	둘 다 양성	HER2 표적치료 + 내분비요법

첫 30일의 지도

순서	할 일	시기
①	조직검사 결과(침윤 여부·아형) 확인	Day 0~3
②	유방 영상(촬영·초음파·필요 시 MRI)·병기 검사	Day 3~14
③	유전자검사 대상 여부, 가임력 희망 알리기	첫 진료
④	수술 먼저 vs 수술 전 약물치료 결정	Day 10~21
⑤	수술 방법(보존·전절제·재건) 또는 항암 준비	Day 14~30

오늘 물어볼 질문

1. 제 암은 0기인가요, 침윤암인가요?
2. 호르몬수용체와 HER2 결과는 어떻게 나왔나요?
3. 저는 수술을 먼저 하나요, 약물치료를 먼저 하나요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자 — 다음 예약까지 기다리지 말고 바로 연락하거나 응급실로

- 항암치료 중 **38°C 이상 발열**이나 오한 → **해열제로 열을 내리기 전에 먼저 병원에 연락**
- 수술 부위가 갑자기 크게 붓고 단단해짐, 고름·악취, 배액관 주위 심한 발적
- 수술한 쪽 팔이 **빨강고 뜨겁게 붓고 열이 남**(봉와직염 가능성)
- 갑작스러운 흉통·숨참, 한쪽 다리 부종(혈전 가능성)
- 항암·표적 주사 중이나 직후 두드러기·얼굴 부종·숨참(과민반응)
- 하루 4~6회 이상 설사·탈수, 물을 마시지 못하는 구토
- 면역치료 중 심한 피로·어지럼, 숨참, 심한 설사·혈변, 눈·피부 노래짐
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ **109**(24시간), 119

본문 목록으로 한 번 더 적습니다.

1. 항암 중 발열은 백혈구 감소에 따른 감염일 수 있어 빠른 평가가 필요합니다.
2. 수술 부위 혈종·감염은 늦게 발견할수록 회복이 길어집니다.
3. 팔의 열감·발적·부종은 림프부종에 생긴 감염일 수 있습니다.
4. 흉통·숨참·한쪽 다리 부종은 혈전·폐색전 가능성이 있습니다.
5. 심한 설사(일부 표적치료제·항암제), 탈수는 신장 기능을 떨어뜨릴 수 있습니다.
6. 면역치료 부작용은 몇 달 뒤에도 생길 수 있습니다.

첫 치료 전에 할 일: 평일 진료실, 야간·휴일 연락처, 가까운 응급실을 내 휴대폰과 보호자 휴대폰에 저장하세요(워크북 W1).

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 세 가지만. ① 조직검사 결과지 받기 ② 유방 전문의 진료 예약 ③ 복용 중인 피임약·여성호르몬제와 임신 계획 정리.

오늘 할 일 (3개)

- ☐ 조직검사 결과지 사본 받기 — 침윤 여부, ER·PR·HER2, Ki-67
- 국내에서는 굵은 바늘 조직검사(총생검)나 진공흡인생검(흔히 '맘모툼')으로 진단하는 경우가 많습니다. 맘모툼으로 보이던 병변이 거의 다 빠졌더라도 암이면 수술 등 치료가 따로 필요합니다. 위치 표시 클립을 넣었는지 확인해 두세요.
- ☐ 유방외과(유방암 수술 전문) 진료 예약
- ☐ **피임약·여성호르몬제**를 먹고 있다면 기록 — 첫 진료에서 바로 알립니다. 임신 가능성이 있으면 검사 전에 말합니다.

이번 주 할 일

- ☐ 영상검사 일정 확인(유방촬영·초음파, 필요 시 유방 MRI, 병기에 따라 CT·뼈스캔·PET/CT)
- ☐ 가족력(유방암·난소암·췌장암·전립선암, 남성 유방암) 정리 → **유전자검사 대상** 여부 묻기
- ☐ 앞으로 임신을 원하면 **가임력 상담 의뢰**를 첫 진료에서 요청
- ☐ 산정특례 신청 여부 원무과 확인(확진일로부터 30일 이내 신청 시 확진일부터 적용, 상피내암 적용 여부 확인)
- ☐ 2차 소견·전원 예정이면 슬라이드·영상 CD 대여 방법 확인

보호자 몫

- ☐ 진료 동행·기록 ☐ 일정 정리 ☐ "왜 검진을 안 받았어" 같은 말 대신 "같이 준비하자"

마음 점검 한 줄

지금 마음의 고통은 0~10 중 ____점. 4점 이상이면 첫 진료에서 그대로 말해도 됩니다. 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 ☎ 109(24시간).

오늘 물어볼 질문

- 1. 제 조직검사 결과에서 아형은 무엇인가요?
- 2. 병기를 정하려면 어떤 검사가 필요한가요?
- 3. 유전자검사와 가임력 상담 대상인가요?

4장. 0기(관상피내암, DCIS)라고 들었다면

30초 요약

- 0기는 암세포가 젖관 밖으로 나가지 않은 **비침윤성** 암입니다. 치료의 목표는 **침윤암으로 진행하거나 다시 생기는 것을 막는 것**이며, 치료 성적이 좋은 편입니다(개인 예후는 담당 의료진 확인).
- 치료는 **수술이 중심**: 유방보존술(± 방사선) 또는 전절제술.
- 호르몬수용체 양성이면 **내분비요법(보통 5년)**이 선택지입니다.

선택지	내용	생각할 점
유방보존술 + 방사선	병변을 깨끗한 절제면과 함께 떼고 방사선	가장 흔한 조합
유방보존술 단독	위험이 낮은 일부(작은 병변·저등급·넓은 절제면·고령 등)에서 방사선 생략을 논의	대상 기준은 담당 의료진 확인
전절제술(± 재건)	범위가 넓거나 여러 곳일 때	감시림프절생검을 함께 하는 경우가 많음

- **감시림프절생검**은 0기에서 보통 필요하지 않지만, **전절제술**을 하거나 침윤암이 의심되면 함께 합니다(전절제 후에는 나중에 하기 어렵기 때문).

- 수술 후 최종 병리에서 **약 10명 중 1명꼴로 침윤암이 함께 발견될** 수 있습니다. 그러면 이 책의 침윤암 장으로 넘어갑니다. "오진"이 아니라 정보가 더해진 결과입니다.
- 절제면에 병변이 남으면 재절제를 권할 수 있습니다.

0기 결정 질문지

1. 제 병변의 크기·등급·절제면은 어떤가요? 방사선 생략을 논의할 수 있나요?
2. 호르몬약을 먹으면 무엇이 줄고, 어떤 부작용이 예상되나요? 안 먹는 선택은요?
3. 전절제를 한다면 재건은 언제 상의하나요?

0기 보험 주의

진단서 질병코드는 상피내암이면 **D05**, 침윤암이면 **C50**입니다. 민간 암보험은 상피내암을 "유사암"으로 분류해 진단비가 다를 수 있습니다. **최종 병리가 나온 뒤** 청구하고, 최종 병리에서 침윤암으로 바뀌면 재청구가 가능한지 보험사에 확인하세요.

5장. 병리보고서와 검사 읽기

30초 요약: 먼저 볼 것은 **침윤 여부 · 조직형 · 등급 · ER/PR(%) · HER2 · Ki-67** 여섯 가지입니다.

HER2 판정 3단계 (가장 많이 헷갈리는 부분)

검사 결과	판정	의미
IHC 3+, 또는 2+ 이면서 ISH 양성	HER2 양성	HER2 표적치료 대상
IHC 1+, 또는 2+ 이면서 ISH 음성	HER2 저발현 — HER2 양성이 아님	주로 전이·재발 때 일부 치료 선택에 의미

검사 결과	판정	의미
IHC 0	HER2 음성	—

IHC 2+는 "경계"라서 ISH(FISH·SISH·DISH 등) 추가검사로 확정합니다.
 결과가 나오기 전까지는 HER2 상태를 ⏳로 두세요.

항목	보고서 표현	의미
ER / PR	positive 90%, Allred 8	내분비요법 효과 예측. ER 1~10% 저발현 양성 은 의미를 따로 물어보세요
등급	Grade 1·2·3 (Nottingham)	높을수록 빨리 자라는 경향
Ki-67	30%	세포 증식 정도. 기관마다 해석 기준이 다름
LVI	lymphovascular invasion	림프관·혈관 침범
절제면	margin	수술 후 재절제 필요성

가상 보고서 한 줄씩 읽기 (예시)

Invasive carcinoma of no special type, histologic grade 2 ER: positive (95%, strong) / PR: positive (40%) HER2: IHC 2+ → SISH: not amplified
 Ki-67: 15%

줄	쉬운 말
no special type, grade 2	가장 흔한 침윤성 유관암, 중간 등급
ER 95%, PR 40%	호르몬수용체 양성 → 내분비요법 대상

줄	쉬운 말
HER2 2+ → SISH not amplified	ISH 음성 → HER2 저발현 (양성 아님)
Ki-67 15%	증식 정도 낮은~중간

→ 이 예시는 **HR+/HER2-** 아형입니다. 다음 질문은
 "21유전자 검사가 필요한가요?"가 될 수 있습니다.

영상검사 카드

검사	목적	흔한 오해
유방촬영·초음파	종양 크기·범위, 거드랑이 림프절	—
유방 MRI	범위 확인(소엽암, 치밀유방, 보존술 계획 등)	모든 환자에게 필수는 아님
CT·뼈스캔·PET/CT	전이 확인	초기(1~2기)는 증상이 없으면 대개 필요하지 않음
판독지의 "결절·섬취 증가"는 전이를 뜻하지 않을 수 있습니다. 추가 검사 필요 여부를 의료진과 확인하세요.		

검사 결과 기록

침윤	조직 형	등 급	E R	P R	HER2	Ki- 67	림프절(영상/ 조직)
☐ 0기 ☐ 침윤			%	%	☐ 양성 ☐ 저발현 ☐ 0 ☐ 	%	

6장. 병기와 유전자검사

30초 요약

- 병기에는 종양 크기(T)·림프절(N)·전이(M)만으로 정하는 **해부학적 병기**와, 여기에 **아형·등급**을 더한 **예후 병기**가 있습니다. 설명이나 결과지마다 숫자가 다를 수 있으니 어느 쪽인지 확인하세요. 수술 전(임상 병기)과 수술 후(병리 병기) 두 번 정해질 수 있습니다.
- **배선(유전) 유전자검사(BRCA1·2 등)**는 대상이 넓어졌습니다. 결과가 수술 범위와 **수술 후 약 선택**에도 쓰일 수 있습니다.

병기	쉬운 뜻
0기	비침윤성(DCIS)
1기	작은 침윤암, 림프절 전이 없거나 미세
2기	종양이 크거나 겨드랑이 림프절 몇 개
3기	림프절 다수·피부/흉벽 침범·염증성 유방암
4기	뼈·폐·간·뇌 등 원격전이

유전자검사 대상이 될 수 있는 경우(예시, 기준은 의료진 확인)

- 비교적 젊은 나이의 진단, 삼중음성, 남성 유방암, 양측 유방암
- 가족 중 유방암·난소암·췌장암·전립선암(고위험)
- 재발 위험이 높아 PARP 억제제 보조요법을 고려하는 경우 결과가 나오면 **가족 상담(유전상담)**과 연결됩니다.

오늘 물어볼 질문

1. 제 임상 병기는 무엇인가요?
2. 유전자검사 대상인가요? 결과가 치료를 바꾸나요?

3. 전이 검사는 제게 필요한가요?

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

7장. 치료 경로 지도: 수술 먼저 vs 약물치료 먼저

30초 요약

- **수술 먼저:** 대부분의 HR+/HER2- 초기암, 작은 HER2 양성·삼중음성.
- **수술 전 약물치료(선행치료) 먼저:** HER2 양성·삼중음성으로 종양이 크거나(대략 2cm 이상) 림프절 양성, 3기, 보존술을 위해 종양을 줄이고 싶을 때.
- 선행치료 후 **남은 암(잔존암)**이 있으면 수술 후 약이 바뀔 수 있습니다.

아형	흔한 순서(범주, 국내 허가·급여 확인 필요)
HR+/HER2- 저위험	수술 → 방사선(보존술 시) → 내분비요법
HR+/HER2- 고위험	수술 → (21유전자 검사 등으로 판단해) 항암 → 방사선 → 내분비요법 + CDK4/6 억제제 보조요법(2~3년) 범주. 배선 BRCA 변이면 PARP 억제제 보조요법 범주
HER2 양성 2기 이상	항암 + HER2 표적치료(이중 표적 포함) → 수술 → 남은 암 없으면 HER2 표적 지속 / 남은 암 있으면 HER2 항체-약물접합체(ADC)로 전환
삼중음성 2기 이상	항암 + 면역치료 → 수술 → 면역치료 지속 / 남은 암 있으면 경구 항암제 또는(배선 BRCA 변이) PARP 억제제 범주
작은(1기) HER2 양성· 삼중음성	수술 먼저 → 병리에 따라 약물치료

수술 전 약물치료를 시작하기 전에 확인할 것

- ☐ 종양에 클립(표지자)을 넣었나요? — 종양이 사라져도 수술 위치를 찾기 위해 필요
- ☐ 겨드랑이 림프절 평가(필요 시 조직검사·클립)
- ☐ 기준 영상 촬영
- ☐ HER2 표적치료 예정이면 심장 기능 검사
- ☐ 가임력 상담·난소 보호 주사 논의, 치과 점검, 항암 주사용 포트 여부

21유전자 검사

HR+/HER2-, 림프절 음성 또는 일부 양성 초기암에서 항암을 더했을 때 이득이 있는지를 예측하는 검증된 검사입니다(대표 예: 온코타입DX). 결과(재발점수)와 나이·폐경 여부를 함께 봅니다. 국내 비용·급여는 확인이 필요합니다.

시나리오로 보는 결정 (가상 사례)

- A. 54세, HR+/HER2-, 1.8cm, 림프절 음성 → 보존술 + 감시림프절 → 21유전자 검사 → 점수에 따라 항암 여부 결정 → 방사선 → 내분비요법.
- B. 45세, HER2 양성, 3cm, 림프절 양성 → 클립 삽입·심장 검사 → 항암 + 이중 HER2 표적 → 수술 → 결과에 따라 표적치료 지속 또는 ADC 전환.
- C. 36세, 삼중음성, 2.5cm → 가임력 상담(약 2주) → 항암 + 면역치료 → 수술 → 남은 암 여부에 따라 추가 치료. 유전자검사 결과도 반영.
- D. 72세, HR+/HER2-, 1.2cm, 림프절 음성, 동반질환 있음 → 보존술 → 감시림프절생검·방사선 생략을 논의할 수 있는 상황 → 내분비요법.

항암 시작 전 14일 체크표

날짜	할 일	완료
D-14~10	가임력 상담·난자/배아 동결 시작(해당 시)	☐
D-10	치과 점검(충치·잇몸 치료)	☐

날짜	할 일	완료
D-7	심장 검사(HER2 표적), 포트 삽입 상담	☐
D-7	가발·두피냉각 여부, 직장 일정 조정	☐
D-3	구토 예방약·발열 시 연락 기준 교육	☐
D-1	체온계 준비, 연락처 카드 휴대	☐

오늘 물어볼 질문

1. 제 아형과 병기에서는 수술과 약물치료 중 무엇을 먼저 하나요?
2. 21유전자 검사나 유전자검사 결과가 치료를 바꿀 수 있나요?
3. 수술 전 치료를 한다면 클립·심장 검사는 언제 하나요?

8장. 수술: 보존술·전절제술·겨드랑이·재건

30초 요약

- **유방보존술 + 방사선**과 **전절제술**은 적합한 환자에서 생존율이 비슷합니다. 선택은 종양 크기·위치·유방 크기, 유전자 결과, 본인의 선호로 정합니다.
- 겨드랑이는 대부분 **감시림프절생검**으로 시작합니다. 전이가 있어도 조건에 따라 **겨드랑이 전체 절제를 피할 수 있는** 경우가 늘었습니다.
- 재건은 **수술 전에** 상의합니다(즉시·지연·평평한 봉합).

비교	유방보존술	전절제술
남는 것	대부분의 유방	유방 없음(재건 또는 평평한 봉합)
방사선	대개 필요	병기에 따라
재수술 가능성	절제면 양성 시 재절제	낮음

비교	유방보존술	전절제술
회복	비교적 빠름	재건 방법에 따라 길어짐

- 작은 HR+/HER2- 1기 종양이고 수술 전 겨드랑이 초음파에서 림프절 이상이 없는 일부(주로 폐경 후)에서는 **감시림프절생검을 생략하는 선택**을, 70세 안팎 이상 고령·저위험 일부에서는 **방사선을 생략하는 선택**을 논의할 수 있습니다 (대상 기준은 담당 의료진 확인).
- 재건: 보형물·자가조직(복부·등 등)·혼합. 흡연은 재건 합병증을 크게 늘립니다.

수술 전 체크

- ☐ 복용 약 정리(혈액을 묽게 하는 약, 호르몬제, 건강기능식품)
- ☐ **양팔 들레·어깨 움직임 기준 측정**(림프부종 비교용, 병원에서 하는지 확인)
- ☐ 재건 상담(성형외과) — 방사선 가능성과 재건 순서
- ☐ 앞여밈 옷·쿠션, 입원·간병 계획

수술 후

- 배액관: 하루 배액량·색 기록. 갑자기 늘거나 피가 진해지면 연락.
- 샤워·운전·무거운 물건 시점은 병원 지시를 따릅니다.
- **어깨 운동**은 보통 수술 후 며칠 안에 가벼운 동작부터, 배액관 제거 후 범위를 늘립니다(병원 안내 우선).
- 겨드랑이 수술 쪽 팔의 상처·화상·벌레 물림을 조심하고, 붓기를 기록합니다.

재건 비교

방법	장점	생각할 점
보형물(확장기 → 보형물)	수술 시간 짧음	방사선 후 구형구축 위험, 단계적 수술

방법	장점	생각할 점
자가조직(복부 등)	자연스러운 촉감	수술 시간·회복 길고 공여부 흉터
평평한 봉합	추가 수술 없음	원하면 나중에 재건 가능

국내 급여 범위는 방법별로 다르니
확인하세요.

수술 기록: 수술명 _ · **겨드랑이 □감시림프절 □겨드랑이 절제 · 재건 □즉시 □**
자연 □안 함 · 최종 병리 날짜 _

오늘 물어볼 질문

1. 저는 보존술과 전절제술 중 어느 것이 가능한가요?
2. 겨드랑이 수술 범위는 어떻게 정하나요?
3. 재건은 언제, 어떤 방법이 가능한가요?

9장. 약물치료: 항암·HER2 표적·내분비·새 보조요법

30초 요약: 약물치료는 아형에 맞춰 조합합니다. 아래는 **범주**이며, 대표 약제는 예시일 뿐입니다(국내 허가·급여 확인 필요).

범주	누구에게	대표 예시	기억할 부작용
항암화학 요법	고위험, HER2 양성, 삼중음성	안트라사이클린·탁산 계열	탈모, 구토, 백혈구 감소 (발열 주의), 손발 저림
HER2 표적치료	HER2 양성	트라스투주맵, 퍼투주맵, HER2 ADC	심장 기능 저하(정기 검사)

범주	누구에게	대표 예시	기억할 부작용
내분비요법	HR 양성	타목시펜, 아로마타제 억제제, 폐경 전 난소기능억제 병용	안면홍조, 관절통, 골밀도 감소, (타목시펜) 혈전·자궁내막 변화
CDK4/6 억제제 (보조)	고위험 HR+/HER2-	아베마시클립(2년), 리보시클립(3년)	설사·백혈구 감소·간수치, 일부 심전도
PARP 억제제 (보조)	배선 BRCA 변이 고위험 HER2-	올라파립(1년)	빈혈, 피로, 메스꺼움
면역치료	2~3기 삼중음성 (선행치료)	팸브롤리주맙	갑상선·피부·장·폐 등 면역 부작용 — 몇 달 뒤에도 가능

- **내분비요법 기간:** 보통 5년, 재발 위험에 따라 7.5~10년까지 논의. 빠뜨리지 않고 먹는 것이 효과의 핵심입니다.
- 아로마타제 억제제를 먹는다면 **골밀도 검사**와 뼈 보호 방법을 함께 상의하고, 뼈 보호 주사 전에는 치과 점검을 합니다.
- 치료 중 임신은 피합니다. 피임은 **비호르몬 방법**(구리 루프, 콘돔 등)을 의료진과 상의하세요.

항암 1주기 부작용 달력(일반적 예시, 3주 주기)

시기	흔한 변화	대처
1~3일	메스꺼움, 피로	처방받은 구토 예방약을 시간 맞춰
7~14일	백혈구 최저점 — 감염 위험	38°C 이상이면 바로 연락 , 사람 많은 곳 줄이기

시기	흔한 변화	대처
2~3주	회복, 탈모 시작(첫 주기 2~3주 뒤)	가발·모자 준비

탈모

대개 일시적입니다. **두피냉각** 장치를 쓸 수 있는 병원도 있습니다(효과·비용 확인).
가발 지원 제도는 2026.10 기준으로 따로 확인하세요.

내분비요법 생활 가이드

- 같은 시간에 복용, 복약 달력 사용. 빠뜨렸을 때 대처는 약사에게 미리 확인.
- 관절통: 걷기·근력운동이 도움. 심하면 약 변경을 상의.
- 안면홍조·질 건조: 비호르몬 대처를 먼저 상의.
- 우울감·불면이 이어지면 말해 주세요. 약을 중단하고 싶을 때도 **스스로 끊기 전에** 상의합니다.

오늘 물어볼 질문

1. 제 아형에 맞는 약물치료 조합과 기간은 어떻게 되나요?
2. 저는 CDK4/6 억제제·PARP 억제제·면역치료 같은 보조요법 대상인가요?
3. 치료 중 피임과 가임력 보존은 어떻게 하나요?

10장. 방사선치료

30초 요약: 유방보존술 후 대부분 방사선을 받습니다. 요즘은 **3주(15회)** **안팎의 짧은 일정**이 흔하고(국내 안내 자료에는 4~6주로 적힌 곳도 있어 병원마다 일정이 다를 수 있습니다), 일부는 1주(5회) 일정이나 부분 유방 조사도 가능합니다. 고령·저위험 일부에서는 생략을 논의합니다.

종류	내용
전유방 조사	유방 전체. 필요 시 종양 자리에 추가 조사(부스트)
부분 유방 조사	종양 주변만. 선택된 저위험군
전절제 후 흉벽 조사	림프절 양성·큰 종양 등
림프절 부위 조사	겨드랑이·쇄골 위·흉골 옆 림프절

- 흔한 부작용: 피부 붉어짐·가려움, 피로. 치료 중반 이후 심해졌다가 끝나고 몇 주 안에 좋아집니다.
- 왼쪽 유방이면 **심장 보호 방법**(숨 참고 조사 등)을 물어보세요.

방사선 상담 질문지

1. 몇 회, 몇 주 일정이고 부스트가 있나요?
2. 심장·폐를 어떻게 보호하나요?
3. 재건을 했거나 할 예정이면 순서는 어떻게 되나요?

피부 관리

- 미지근한 물, 순한 세정제, 문지르지 않기. 병원이 권한 보습제 사용.
- 치료 부위 제모·뜨거운 찜질·강한 햇빛 피하기.
- 물집·진물이 생기면 연락합니다.

11장. 전이성(4기) 유방암으로 진단받았다면

30초 요약

- 전이 부위 **조직검사로 아형을 다시 확인**합니다(처음과 달라질 수 있음).
- 치료는 아형에 따라 내분비요법 + 표적치료, HER2 표적치료, 항암·ADC·면역치료 등을 조합하며, 많은 사람이 **오랜 기간 치료를 이어 갑니다**.
- 추가 검사(PIK3CA·ESR1 등 유전자, 배선 BRCA, HER2 저발현, PD-L1)가 다음 치료 선택에 쓰입니다.

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다**. 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

치료 목표를 묻는 질문

1. 이 치료의 목표는 무엇인가요? (암 크기 줄이기 / 진행 늦추기 / 증상 줄이기)
2. 치료 효과는 언제, 어떤 검사로 확인하나요?
3. 이 치료를 받지 않거나 쉬면 어떤 일이 예상되나요?

완화의료 이용하기

- 대부분의 암 병원에 **완화의료팀(자문형)**이 있습니다. 통증, 숨참, 메스꺼움, 불면, 불안 조절을 담당 교수에게 요청하면 연결됩니다.

- 호스피스·완화의료는 입원형·가정형·자문형으로 나뉘며, 지정 기관과 이용 조건은 국립암센터 중앙호스피스센터 누리집이나 병원 사회사업팀에서 확인합니다.
- 완화의료를 받는다고 해서 항암치료를 포기하는 것이 아닙니다.

미리 생각해 둘 것(원할 때만)

- **사전연명의료의향서:** 19세 이상이면 건강할 때도 작성할 수 있습니다. 보건소·지정 등록기관에서 작성하며, 언제든지 변경·철회할 수 있습니다 (국립연명의료관리기관).
- 치료를 잠시 쉬거나 멈추는 선택도 존중되는 결정입니다. 결정은 한 번에 하지 않아도 됩니다.
- 내가 직접 말하기 어려워질 때 나 대신 의견을 전할 사람을 정해 가족에게 알려 둡니다.

2차 소견과 병원 선택

30초 요약

- 2차 소견은 담당 의사를 의심하는 일이 아니라 **큰 결정을 확인하는 일**입니다. 대부분의 의사는 자연스럽게 받아들입니다.
- 2차 소견 때문에 치료를 몇 주씩 미루지 않도록 **일정을 먼저 정하고** 움직입니다.
- 가장 중요한 준비물은 병리 슬라이드·블록과 영상 CD입니다.

2차 소견이 특히 도움이 되는 경우

- 병리 결과가 드문 조직형이거나, 병원마다 해석이 갈릴 수 있다고 들었을 때
- 수술과 비수술 치료 중 선택지가 둘 이상일 때
- 기능 보존 수술이나 드문 치료처럼 경험 많은 센터가 중요한 치료일 때

- 설명을 들었는데도 결정이 서지 않을 때

병원을 고를 때 물어볼 것

1. 이 병원에서 유방암 환자를 **다학제(여러 과가 함께 보는) 진료**로 상의하나요?
2. 제게 필요한 치료(수술·방사선·항암·임상시험 등)를 **한 병원**에서 받을 수 있나요?
아니면 연계 병원이 정해져 있나요?
3. 치료 중 밤이나 휴일에 문제가 생기면 **어디로 연락**하나요?
4. 첫 치료까지 대략 몇 주가 걸리나요?

집과의 거리도 중요한 기준입니다. 매일 가야 하는 방사선치료나 잦은 외래가 예정되어 있다면, 통원 부담과 응급 시 이동 시간을 함께 따져 보세요.

2차 소견 준비 체크리스트

- ☐ 진료의뢰서(상급종합병원은 필수)
- ☐ 병리보고서 + 슬라이드/블록 대여
- ☐ 영상 CD + 판독지
- ☐ 혈액검사 결과, 복용 약 목록
- ☐ 내가 가장 궁금한 질문 3개(워크북 「질문지」)

최신 치료와 임상시험

- 임상시험은 "마지막에 기대는 실험"만이 아닙니다. 진단 초기부터 **표준치료와 함께 고려할 수 있는 선택지**입니다.
- 임상시험에 참여해도 언제든 그만둘 수 있고, 위약(가짜약)만 단독으로 쓰는 암 임상시험은 드뭅니다. 위약이 포함되면 사전에 설명을 듣습니다.
- 연구 약값은 보통 연구 쪽이 부담하지만, 교통비·추가 방문 등 부대 비용은 확인이 필요합니다.

찾는 곳

- 담당 교수에게 "제가 참여할 수 있는 임상시험이 있나요?"라고 직접 묻기 — 가장 빠릅니다.
- 한국임상시험포털(KoNECT), 식품의약품안전처 의약품안전나라 임상시험 정보, ClinicalTrials.gov(영문)

물어볼 질문

1. 이 연구는 무엇을 비교하나요? 표준치료를 받지 못하게 되나요?
 2. 방문 횟수와 검사가 얼마나 늘어나나요?
 3. 중간에 그만두면 어떤 치료를 받게 되나요?
-

PART 3. 30일 실행 로드맵

Day 0-3 · 확인하기

- ☐ 조직검사 결과지(침윤·아형) ☐ 유방외과 예약 ☐ 호르몬제 복용·임신 계획 정리 ☐ 연락처 저장 ☐ 산정특례 문의

Day 4-7 · 검사받기

- ☐ 유방 영상(MRI 해당 시) ☐ 병기 검사(해당 시) ☐ 가족력 정리·유전상담 의뢰 ☐ 가임력 상담 예약

Day 8-14 · 결정하기

- ☐ 수술 먼저 vs 선행치료 결정 ☐ 보존술/전절제/재건 상담 ☐ 21유전자 검사 여부 ☐ 필요 시 2차 소견

Day 15-21 · 준비하기

- ☐ 수술 경로: 팔 기준 측정·수술 전 검사·간병 계획
- ☐ 선행치료 경로: 클립·심장 검사·포트·치과·14일 체크표
- ☐ 직장 일정 조정, 보험 서류 목록 확인

Day 22-30 · 시작하기

- ☐ 첫 치료 ☐ 증상 일지(W3) ☐ 발열 시 연락 기준 재확인 ☐ 가족에게 일정 공유 ☐ 나를 위한 30분
-

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

림프부종·어깨·신체상

30초 요약: 겨드랑이 수술·방사선 뒤 팔이 붓거나 묵직하면 일찍 알려주세요. 일찍 관리할수록 좋습니다. 유방의 변화와 탈모로 인한 신체상 고민은 흔하며, 말해도 되는 주제입니다.

주	팔 둘레(손목 위 10cm / 팔꿈치 위 10cm)	묵직함 0~10	메모
수술 전	/		기준
2주	/		
4주	/		

- 양팔 차이가 커지거나 반지·시계가 끼면 재활의학과 상담.
- 운동(근력 포함)은 림프부종을 악화시키지 않으며, 단계적으로 늘리는 것이 도움이 됩니다.
- 압박 슬리브 급여 여부는 확인 필요.
- 파트너와의 관계, 몸이 달라진 느낌은 혼자 감당하지 않아도 됩니다. 병원 상담·성재활·환우 모임을 이용하세요.

추적

항목	일반적 예시(개인별로 다름)
진찰	5년간 1년에 1~4회, 이후 매년
유방촬영	매년(전절제·재건한 쪽은 제외)
골밀도	아로마타제 억제제·조기폐경 시

항목	일반적 예시(개인별로 다름)
부인과 진찰	나이에 따라. 타목시펜 복용 중 질 출혈은 바로 알리기. 증상이 없을 때 정기 자궁내막 초음파는 국제 지침에서 일상적으로 권하지 않지만, 국내에는 권하는 병원도 있으니 확인
- 증상이 없을 때 정기적인 CT·빠스캔·종양표지자 검사는 대개 권하지 않습니다.	
- 알릴 증상: 새 덩어리, 지속되는 뼈 통증, 걸을 때 숨참, 지속 두통, 질 출혈 (타목시펜).	

치료 중 흔한 증상, 집에서 할 일과 연락 기준

아래는 여러 암 치료에서 공통으로 흔한 증상입니다. **치료 병원의 안내가 항상 우선**이며, "연락" 칸에 해당하면 다음 예약까지 기다리지 마세요.

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
메스꺼움·구토	처방받은 구토 예방약을 시간 맞춰 (증상이 생긴 뒤가 아니라 미리). 조금씩 자주, 차갑고 냄새가 약한 음식, 생강차·크래커	하루 3회 이상 구토, 물도 못 마심, 24시간 소변이 거의 없음
피로	짧은 낮잠(30분 이내), 가벼운 걷기, 우선순위 정해 에너지 아끼기, 도움 요청	숨참·어지럼·심한 창백(빈혈 가능), 일상생활이 불가능
입안 혈음	부드러운 칫솔, 무알코올 가글(소금·베이킹소다 물), 자극적·뜨거운 음식 피하기	통증으로 먹거나 마시지 못함, 흰 반점·출혈, 발열 동반

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
변비	수분, 걷기, 처방 변비약. 진통제(마약성) 복용 중이면 변비약을 미리 함께	3일 이상 변이 없고 복통·구토, 배가 부풀
설사	수분·전해질(이온음료 희석, 미음), 기름진 음식·유제품·카페인 줄이기, 처방 지사제	하루 4~6회 이상, 밤에도 계속, 혈변, 어지럼·소변 감소, 면역치료 중 설사
불면	일정한 기상 시간, 낮잠 제한, 잠자리에서 휴대폰 멀리, 스테로이드는 아침 복용 (지시대로)	2주 이상 계속, 불안·우울 동반
탈모	순한 샴푸, 짧은 머리, 모자·두건·가발, 두피 자외선 차단	— (대개 치료 후 다시 자람)
피부 발진·건조	순한 보습제 하루 2회 이상, 미지근한 물, 자외선 차단	물집·벗겨짐, 넓게 번짐, 점막 (입·눈) 침범
손발 저림	찬 것 피하기(일부 약), 따뜻한 양말·장갑, 낙상 주의	단추·젓가락·걸기가 어려워짐 — 다음 투여 전에 꼭 알리기
식욕 저하·체중 감소	먹을 수 있을 때 먹기, 고단백 간식, 영양 보충 음료	한 달 5% 이상 체중 감소, 평소의 절반 이하로 1주 이상

열이 나면: 항암 중 38°C 이상(병원 기준에 따라 37.8°C 이상 1시간 지속 등)은 **해열제를 먹기 전에 먼저 연락**하는 것이 원칙입니다. 열을 내리면 감염 신호를 놓칠 수 있습니다.

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

내 마음 온도계(고통 선별)

지난 1주일 동안 내 마음의 고통은 몇 점이었나요? (0 = 전혀 없음, 10 = 극심함)

날짜 점수(0~10) 가장 힘든 것(☐ 걱정 ☐ 잠 ☐ 통증 ☐ 돈 ☐ 가족 ☐ 일 ☐ 기타)

- **4점 이상**이 계속되면 다음 진료 때 점수를 그대로 말하세요. 대부분의 암 병원에는 정신건강의학과·임상심리·사회사업팀 연결 경로가 있습니다.
- 불면이 1~2주 이상 계속되면 수면 치료를 받을 수 있습니다. 잠은 치료를 견디는 체력입니다.
- 병원 밖 도움: 전국 지역암센터의 **암생존자통합지지센터**(☎ 1577-9740)에서 상담·심리지지·자기관리 프로그램을 운영합니다. 암 정보가 궁금하면 국가암지식정보센터 상담(☎ 1577-8899, 평일 9~18시)을 이용할 수 있습니다.

불안이 물려올 때 5분 방법

1. **숨:** 4초 들이쉬고, 6초 내쉬기를 5번.
2. **이름 붙이기:** "지금 나는 ○○ 결과가 걱정된다"라고 소리 내거나 적기.

3. **내 몫 나누기**: 지금 내가 할 수 있는 일 1개(전화 1통, 서류 1장)와 의료진 몫을 나눠 적기.
4. **정보 시간 정하기**: 인터넷 검색은 하루 30분, 정해 둔 시간에만. 밤 검색은 불안을 키웁니다.

"내 탓일까?"라는 생각

암은 한 가지 원인으로 생기지 않습니다. 생활습관, 감염, 유전, 나이, 그리고 설명되지 않는 우연이 겹칩니다. **원인 찾기보다 지금부터의 계획**에 에너지를 쓰는 편이 나를 돕습니다. 가족이나 주변 사람이 원인을 따져 묻는다면 "지금은 치료 계획에 집중하고 싶어"라고 말해도 됩니다.

희망과 현실을 함께 들고 가기

통계(생존율)는 많은 사람의 평균이지 나 한 사람의 예언이 아닙니다. 궁금하다면 담당 의사에게 "제 병기와 상태에서 치료 목표가 무엇인가요?"라고 물어보세요. 듣고 싶지 않은 정보는 "지금은 듣지 않겠다"고 말할 권리도 있습니다.

보호자에게

보호자가 첫 30일에 할 수 있는 가장 좋은 일

- **기록 담당**: 진료실에서 답을 적습니다. 환자는 듣는 데 집중할 수 있습니다.
- **일정 담당**: 검사·진료·서류 일정을 한 곳(달력·앱)에 모읍니다.
- **연락 창구**: 친척·지인에게 소식을 전하는 사람을 한 명으로 정하면 환자가 같은 이야기를 반복하지 않아도 됩니다.
- **결정은 환자가**: 의견은 말하되, 치료 결정의 주인은 환자입니다.

피하면 좋은 말과 바꿔 쓸 말

피하면 좋은 말	바꿔 쓸 말
"긍정적으로 생각해야 나아"	"힘든 마음 그대로 말해도 돼"
"왜 검진을 안 받았어"	"지금부터 같이 챙기자"
"○○ 먹으면 낫는데"	"새로 먹고 싶은 게 있으면 의사 선생님께 같이 물어보자"
"너보다 더 힘든 사람도 있어"	"네가 힘든 건 힘든 거야"

아이에게 알릴 때

- 아이의 나이에 맞게, **짧고 사실대로**: "(엄마·아빠·할머니 등 아이가 부르는 호칭)가 몸에 아픈 곳이 생겨서 병원에서 치료를 받을 거야."
- 아이가 자주 하는 걱정 세 가지에 먼저 답합니다: **네 탓이 아니야 / 윗은 병이 아니야 / 누가 너를 돌봐줄지 정해져 있어.**
- 학교 담임에게 알릴지, 누가 알릴지 미리 정합니다.

보호자의 휴가 제도

일하는 보호자는 **가족돌봄휴직**(연간 최대 90일)과 그 안에서 하루 단위로 쓰는 **가족돌봄휴가**(연간 최대 10일)를 회사에 신청할 수 있습니다(남녀고용평등법, 2026.10 기준·고용노동부 확인). 진료 동행이 잦은 첫 30일에 특히 유용합니다.

보호자 자신을 위해

보호자의 소진은 흔합니다. 하루 30분은 나를 위한 시간을 지키세요. 병원 사회사업팀과 환우·보호자 모임은 보호자도 이용할 수 있습니다.

직장과 일상

- **언제·누구에게·얼마나** 말할지는 내가 정합니다. 직속 상사와 인사 담당자에게 "치료 일정 때문에 근무 조정이 필요하다" 정도만 알려도 충분한 경우가 많습니다.
- 치료 일정이 나오면 **근무 조정안**(단축근무, 재택, 연차·병가 조합)을 내가 먼저 제안하면 협의가 쉬워집니다.
- 피로는 치료 중 가장 흔한 증상입니다. 치료 직후 며칠은 일을 줄이는 계획을 미리 세웁니다.
- 자영업자라면 매출보다 **현금 흐름 3개월**을 먼저 계산하고, 사회사업팀에 지원제도를 문의합니다.
- 복귀는 한 번에 100%가 아니라 단계적으로. 복귀 시점은 담당 의사와 상의합니다.
- 암생존자통합지지센터(☎ 1577-9740)에는 직장·학교 복귀를 돕는 프로그램이 있습니다(지역별 운영 확인).

먹는 것과 움직이는 것

식사 원칙

- 치료 중 목표는 "특별한 음식"이 아니라 **체중과 근육 유지**입니다. 고른 식사와 충분한 단백질(생선·달걀·두부·살코기·유제품)을 챙깁니다.
- 암 치료에 특별히 좋은 음식이나 꼭 피해야 할 "나쁜 음식"이 따로 정해져 있지는 않습니다. "좋은 음식"만 먹거나 여러 음식을 가리면 오히려 영양이 치우치고 체력이 떨어져 치료를 버티기 어려워집니다.
- 입안이 험했을 때는 잡곡밥보다 부드러운 흰쌀밥이 나올 수 있고, 체중이 줄고 있다면 기름을 지나치게 제한할 필요도 없습니다. 유기농 식품이 치료에 특별히 도움이 된다는 근거는 뚜렷하지 않습니다.

- 체중이 한 달에 5% 이상 줄거나 먹는 양이 평소의 절반 이하로 1주 이상 이어지면 영양 상담을 요청합니다.
- 항암치료 중 면역이 떨어질 때는 날음식·덜 익힌 고기·살균 안 된 유제품을 피하라는 안내를 받을 수 있습니다. 병원 안내를 따르세요.
- **건강기능식품·한약·즙·고용량 비타민**은 항암제나 수술·방사선과 상호작용하거나 간·신장에 부담을 줄 수 있습니다. 시작 전에 꼭 의료진과 약사에게 보여 주세요.

움직이기

- 걷기처럼 가벼운 활동은 피로와 기분을 개선하는 근거가 있습니다. 컨디션에 맞춰 하루 10분부터 시작합니다.
 - 일반적인 건강 목표는 주 150분 중간 강도 활동이지만, 치료 중에는 **할 수 있는 만큼**이 기준입니다.
 - 발열, 심한 빈혈·어지럼, 뼈 전이 통증, 수술 직후에는 운동 강도를 의료진과 상의합니다.
 - 담배는 상처 회복과 치료 효과, 다른 암 위험에 모두 영향을 줍니다. 금연 클리닉(보건소)과 금연상담전화 ☎ **1544-9030**을 이용하세요.
-

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

- 1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
- 2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
- 3. **제도는 바뀔니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

1. 산정특례(중증질환 본인부담 경감)

항목	내용(2026.10 기준, 확인 필요)
대상	암으로 확진된 환자(유방암 포함). 상피내암(0기)·경계성 종양 등은 대상·비율이 다를 수 있어 원무과 확인
혜택	건강보험 급여 진료비의 본인부담 약 5%(입원·외래). 비급여·선별급여는 해당하지 않거나 비율이 다름
기간	적용 시작일(확진일 또는 신청일)부터 5년. 5년 뒤 남아 있는 암·재발·전이가 있으면 재등록 심사
신청 시한	확진일로부터 30일 이내 신청하면 확진일부터 적용. 그 뒤에 신청하면 신청일부터 적용
방법	진단한 의사가 산정특례 등록 신청서를 작성 → 대부분 병원 원무과가 공단에 전송. 직접 제출도 가능

확인할 것

- ☐ 병원이 대신 접수했는지, 등록 결과(문자·공단 앱)를 받았는지
- ☐ 다른 병원으로 옮겨도 산정특례는 유지됩니다. 새 병원 원무과에 등록 사실만 알리면 됩니다.
- ☐ 확진 전 검사비는 적용 시점에 따라 경감되지 않을 수 있습니다.

2. 의료비 부담을 덜어주는 제도

제도	핵심	문의
본인부담상한제	1년간 낸 건강보험 본인부담금이 소득 구간별 상한을 넘으면 남은 금액을 돌려받음(비급여 제외)	국민건강보험공단 1577-1000
재난적 의료비 지원	소득·재산 기준을 충족하고 의료비 부담이 큰 경우 일부 지원(비급여 일부 포함)	공단 지사·병원 사회사업팀
국가 암환자 의료비 지원	의료급여 수급자·차상위 등 해당자 대상 지원	주소지 보건소
병원 사회사업팀 (의료사회복지사)	후원 연계, 간병·교통·숙소 정보, 제도 신청 도움	진료 병원 사회사업팀

대상 기준과 금액은 해마다 바뀝니다. "내가 해당되는지"는 병원 사회사업팀에 한 번에 물어보는 것이 가장 빠릅니다.

3. 보험 청구 서류 체크리스트

민간 암보험(진단비)

- ☐ 진단서(질병분류코드 포함) — 보험사 양식이 있는지 먼저 확인
- ☐ 조직병리검사 결과지(병리보고서) — 대부분의 약관이 병리 확정을 요구합니다

- □ 약관에서 "**유사암·소액암**"(갑상선암, 제자리암/상피내암, 경계성 종양, 기타 피부암 등) 분류를 확인 — 진단비가 다를 수 있습니다
- □ 청구 기한(보험금 청구권 소멸시효는 3년)

실손의료보험

- □ 진료비 영수증 + 진료비 세부산정내역서(비급여 항목 확인용)
- □ 일정 금액 이상은 진단서·입퇴원확인서 추가
- □ 가입 시기에 따라 보장 범위(비급여 주사·도수 등)가 다릅니다

보험 상담에서 "진단서는 몇 통이 필요한가요?"를 먼저 물어보고, 병원에서는 한 번에 필요한 부수만큼 발급받으면 비용과 시간을 아낄 수 있습니다.

4. 회사·학교에 낼 서류

- □ 진단서 또는 소견서(치료 예정 기간 포함 여부 확인)
- □ 회사 취업규칙의 **병가·질병휴직** 조항 확인 — 법정 의무 병가는 없고 회사 규정에 따름(공무원·교원은 별도 규정)
- □ 상병수당: 일부 지역 시범사업 중 — 거주 지역·자격을 공단에 확인
- □ 개인 의료정보는 **필요한 만큼만** 알립니다. 병명 공개 범위는 내가 정합니다 (PART 4 「직장과 일상」 참고).

5. 진료 서류 모아두기(2차 소견·전원 대비)

서류	어디서	메모
병리보고서(조직검사 결과지)	진단 병원 의무기록팀	바이오마커 결과 포함 여부
병리 슬라이드·파라핀 블록 대여	진단 병원 병리과	다른 병원 재판독·추가검사에 필요. 반납 기한 확인

서류	어디서	메모
영상 CD + 판독지	진단 병원 영상의학과· 의무기록팀	CT·MRI·PET 모두
혈액검사 결과	의무기록팀	최근 것
진료의뢰서(소견서)	담당 의사	상급종합병원 외래는 의뢰서가 있어야 건강보험 적용

유방암 참고: 질병코드는 침윤암 C50, 상피내암 D05입니다. 상피내암은
산정특례 적용 기준과 민간보험 진단비가 침윤암과 다를 수 있으니 원무과·
보험사에 따로 확인하세요.

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 3개만 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다.

- 1. 제 암은 0기인가요, 침윤암인가요?
- 2. ER·PR·HER2(저발현 포함)·Ki-67 결과는 무엇인가요?
- 3. 임상 병기와 림프절 상태는 어떤가요?
- 4. 수술을 먼저 하나요, 약물치료를 먼저 하나요?
- 5. 보존술·전절제·재건 중 무엇이 가능한가요?
- 6. 21유전자 검사·배선 유전자검사가 필요한가요?
- 7. 보조요법(CDK4/6·PARP·면역치료) 대상인가요?
- 8. 방사선은 몇 주, 어떤 방식인가요?
- 9. 가임력 보존과 피임은 어떻게 하나요?
- 10. 치료 중 바로 연락해야 할 증상은 무엇인가요?

내 유방암 한 장 요약

항목	내 기록
진단	0기(DCIS) / 침윤암(조직형 ____)
아형	HR+/HER2- · HER2 양성 · 삼중음성 · HR+/HER2+
ER / PR / HER2 / Ki-67	% / % / _ / %
병기	임상 _ → 병리 _ ( / )
림프절	_____

항목	내 기록
유전자검사	배선 _ · 21유전자 점수 _
첫 치료	수술 / 선행 약물치료 / 기타
수술	보존술 / 전절제 / 재건 _____
가임력	해당 없음 / 상담 예정 / 완료
산정특례	☐ 신청 ☐ 완료

오늘 꼭 물을 3가지: ① 제 아형과 병기는? ② 수술이 먼저인가요, 약물치료가 먼저인가요? ③ 유전자검사·가임력 상담을 지금 시작해야 하나요?

같은 진단, 다른 30일 — 세 사람의 이야기 (가상 사례)

감수단 환자 페르소나를 바탕으로 재구성한 가상의 이야기입니다. 실제 인물과 무관하며 치료 결과를 예측하지 않습니다.

48세 현주 씨 — 0기(DCIS) "암인데 암이 아니라는 말"이 가장 혼란스러웠다. 담당의는 "젖관 안에 머문 비침윤성 암"이라고 설명했다. 보존술 후 방사선 생략을 물었더니, 병변 크기와 절제면을 보고 함께 정하자고 했다. 보험 청구는 최종 병리가 나온 뒤에 했다. "D05라는 코드 하나로 진단비가 달라질 수 있다는 걸 미리 알아서 덜 당황했어요."

36세 소연 씨 — 삼중음성 2기 항암 시작까지 2주. 그 안에 난자 동결, 치과, 포트, 휴직 서류, 가발까지 해야 했다. 14일 체크표를 냉장고에 붙이고 하나씩 지웠다. 유전자검사 결과도 기다리는 중이다. "두려운 건 그대로인데, 할 일이 표로 보이니까 숨이 쉬어졌어요."

67세 영숙 씨 — HR+ 1기, 당뇨·골다공증 호르몬약을 5년, 길면 10년 먹어야 한다는 말에 뼈가 걱정됐다. 골밀도 검사와 뼈 보호 주사, 그 전에 치과 점검까지

일정에 넣었다. 딸은 큰 글씨로 만든 한 장 요약을 들고 진료에 동행한다. "약을 오래 먹는 게 치료의 큰 부분이라는 걸 이해하니, 빠뜨리지 않게 되더라고요."

용어사전

용어	쉬운 뜻
DCIS(관상피내암)	젖관 안에 머문 0기 암
침윤성 유관암/소엽암	젖관/소엽에서 시작해 주변으로 퍼진 암
ER·PR(호르몬수용체)	여성호르몬에 반응하는 표지. 양성이면 내분비요법
HER2 양성/저발현	HER2 단백질 과발현 여부. 저발현은 양성인 아님
ISH(FISH·SISH)	HER2 유전자 증폭을 보는 추가검사
Ki-67	세포 증식 지표
선행치료	수술 전에 하는 약물치료
병리학적 완전관해 (pCR)	수술 전 치료 후 수술 조직에 침윤암이 남지 않음. 완치와 같은 말은 아님
잔존암	수술 전 치료 후에도 남은 암
감시림프절생검	암이 처음 퍼지는 림프절만 떼어 검사
내분비요법 (호르몬치료)	호르몬 작용을 막는 약물치료. 폐경 후 '호르몬 대체요법'과 다름
난소기능억제	주사 등으로 난소 호르몬을 멈추게 하는 치료
CDK4/6 억제제	세포분열을 늦추는 표적치료제
PARP 억제제	BRCA 변이 암세포의 DNA 복구를 막는 약
ADC(항체-약물접합체)	항체에 항암제를 붙인 약

용어	쉬운 뜻
21유전자 검사	항암 추가 이득을 예측하는 유전자 발현 검사
림프부종	림프액이 고여 팔이 붓는 상태
평평한 봉합	전절제 후 재건 없이 평평하게 봉합

자주 묻는 질문 13

Q1. 진단받고 수술까지 몇 주가 걸리는데, 그사이 암이 퍼지지 않을까요? 검사와 계획에 필요한 몇 주는 대부분의 유방암에서 결과에 큰 영향을 주지 않는 것으로 알려져 있습니다. 불안하다면 "제 경우 언제까지 시작하는 것이 적절한가요?"라고 구체적으로 물어보세요.

Q2. 유방보존술을 하면 전절제보다 재발이 많지 않나요? 적합한 환자에서 보존술 + 방사선은 전절제와 생존율이 비슷합니다. 같은 쪽 유방 재발은 조금 다를 수 있으나 전체 결과는 비슷합니다. 선택은 종양·유방 크기, 유전자 결과, 본인의 선호로 정합니다.

Q3. 양쪽을 다 떼는 게 더 안전하지 않나요? 유전 변이(BRCA 등)가 없는 경우, 건강한 반대쪽 유방을 예방적으로 떼는 것이 생존율을 높인다는 근거는 제한적입니다. 유전자 결과와 함께 상의하세요.

Q4. HER2 저발현이면 HER2 표적치료를 받나요? 초기 유방암에서 HER2 저발현은 HER2 양성 치료 대상이 아닙니다. 주로 전이·재발 때 일부 약 선택에 의미가 있습니다.

Q5. 21유전자 검사 점수가 중간이면요? 나이·폐경 여부·림프절 상태에 따라 해석이 달라집니다. 점수와 함께 "항암을 더했을 때 기대 이득"을 물어보세요.

Q6. 항암을 하면 머리카락은 언제 빠지고 다시 나나요? 보통 첫 항암 2~3주 뒤 빠지기 시작하고, 항암이 끝나고 몇 달 안에 다시 자랍니다. 두피냉각은 일부 약에서 탈모를 줄일 수 있습니다.

Q7. 호르몬약을 먹으면 살이 찌거나 우울해지나요? 안면홍조·관절통·질 건조가 흔하고, 기분 변화가 생기는 사람도 있습니다. 대부분 관리할 수 있고, 약을 바꿀 수도 있으니 **스스로 끊기 전에** 상의하세요.

Q8. 치료 중 임신하면 어떻게 하나요? 치료 후에는 임신할 수 있나요? 치료 중에는 비호르몬 피임이 권장됩니다. 치료 후 임신 시기는 아형과 치료에 따라 다르며, 내분비요법 중간에 임신을 위해 잠시 쉬는 방법을 연구한 근거도 있습니다. 담당의와 계획을 세우세요.

Q9. 콩·두유는 먹어도 되나요? 일반적인 식사량의 콩 음식은 괜찮다는 것이 대체적인 견해입니다. 농축 보충제(이소플라본 정제 등)는 피하거나 상의하세요.

Q10. 수술한 쪽 팔로 채혈·혈압 측정을 하면 안 되나요? 겨드랑이 림프절을 많이 떼낸 경우 가능하면 반대쪽을 쓰도록 권하는 병원이 많습니다. 감시림프절생검만 했다면 제한이 적을 수 있으니 병원 안내를 따르세요.

Q11. 남성도 유방암에 걸리나요? 드물지만 생깁니다. 치료 원칙은 비슷하고, 유전자검사(BRCA2 등)가 특히 권장됩니다.

Q12. 딸·자매도 검진을 받아야 하나요? 국가 유방암 검진은 만 40세 이상 여성이 2년마다 유방촬영을 받습니다. 가족 중 젊은 나이의 유방암·난소암이 있거나 유전 변이가 확인되면 더 일찍 시작하거나 MRI를 더할지 유전상담에서 정합니다.

Q13. 다른 사람에게 언제, 어떻게 알려야 할까요? 내가 정하면 됩니다. 일정이 정해진 뒤 "치료 때문에 몇 달 일정 조정이 필요해" 정도로 시작해도 충분합니다.

진료실 대화법: 15분 진료를 30분처럼

30초 요약: 질문은 3개로 줄여 가져가고, 보호자가 적고, 마지막에 "제가 이해한 것이 맞는지 말해 볼게요"로 확인합니다.

진료 전달

- 질문 3개를 우선순위로 적기(워크북 W2)

- □ 지난 진료 이후 바뀐 증상·약을 한 줄씩
- □ 검사 결과지·영상 CD·복용 약 목록 챙기기

진료실에서

1. 첫 문장으로 가장 중요한 것부터: "오늘 가장 궁금한 건 첫 치료가 무엇이고 언제 시작하는지예요."
2. 어려운 말이 나오면: "그 말을 쉽게 다시 설명해 주시겠어요?" "종이에 적어 주실 수 있나요?"
3. 선택지가 나오면: "선택지마다 장점과 단점, 그리고 선생님이라면 무엇을 고르실지 여쭙봐도 될까요?"
4. 끝나기 전: "제가 이해한 대로 말해 볼게요. ○○하고, 다음은 ○월 ○일 ○○ 검사죠?"
5. 연락처: "집에서 문제가 생기면 누구에게 연락하나요?"

녹음하고 싶다면

진료 내용을 기억하기 위해 녹음하고 싶을 때는 **먼저 의료진에게 양해를 구하세요.**
허락이 어려우면 보호자 기록으로 대신합니다.

다학제 진료

여러 과(수술·종양내과·방사선종양학과·영상의학과·병리과 등)가 한자리에서 치료를 상의하는 진료입니다. 치료 선택지가 여럿이거나 순서가 중요한 경우 "다학제 진료를 받을 수 있나요?"라고 물어보세요.

검사 준비 카드

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
CT(조영)	몇 시간 금식(병원 지시), 물 충분히(제한 없을 때)	조영제 알레르기, 신장 기능 저하, 당뇨약 (메트포르민), 임신 가능성	촬영은 10~20분
MRI	금속 제거, 일부는 금식	심박동기·인공와우·몸속 금속, 폐소공포증(진정 상담), 신장 기능	30~60분
PET/CT	(FDG PET) 4~6시간 금식, 전날 격한 운동 피하기 · 다른 종류의 PET은 병원 안내	당뇨(혈당 조절법 미리 확인), 임신·수유	주사 후 대기 포함 2~3시간
조직검사 (바늘)	금식 여부 확인	혈액을 묽게 하는 약(중단 여부는 의료진 지시), 알레르기	시술 후 관찰 수시간
내시경	금식, 대장은 장 정결제	혈액을 묽게 하는 약, 당뇨약	진정 시 보호자 동행·당일 운전 금지
뼈스캔	주사 후 물 많이 마시기	임신·수유	주사 후 2~4시간 대기

검사 결과는 "검사를 한 날"이 아니라 **"결과 설명을 듣는 날"**을 미리 예약해 두면 기다리는 불안이 줄어듭니다.

워크북

이 장은 오려 쓰거나 복사해 쓰도록 만들었습니다. 진료실에는 이 페이지만 들고 가도 됩니다.

W1. 비상 연락처 카드 (휴대폰 사진으로도 저장)

항목	기록
담당 교수 / 진료과	
평일 진료실·외래 간호사실 ☎	
야간·휴일 연락처 ☎	
가까운 응급실(치료 병원 우선)	
항암·방사선 치료실 ☎	
보호자 1 / 보호자 2 ☎	
국가암지식정보센터 암정보 상담(평일 9~18시)	☎ 1577-8899
암생존자통합지지센터(지역암센터)	☎ 1577-9740
응급 119 · 정신건강 위기 109	

W2. 진료 기록지 (진료마다 1장)

항목	기록
날짜 / 진료과 / 의사	
오늘 들은 진단·병기	✓ / ⏳ / ?
오늘 결정된 것	

항목	기록
다음 검사·날짜	
다음 진료 날짜	
새로 받은 약	
꼭 지켜야 할 주의사항	
다음에 물어볼 것	

W3. 7일 증상 일지

날 짜	체온 (최고)	통증 0~10	식사(평소의 %)	배변· 배뇨	잠	기분 0~10	메모·연락 여부

W4. 복용 약·보충제 목록 (모든 진료에 지참)

이름	용량·횟수	왜 먹나	처방한 곳	의료진에 알림
				☐
				☐
				☐
				☐

혈액을 묽게 하는 약(항응고제·항혈소판제), 당뇨약, 한약·건강기능식품은
수술·시술·항암 전에 특히 중요합니다.

W5. 30일 체크 달력

주	날짜	한 일(✔) / 남은 일(⌚)
1주	Day 0-7	
2주	Day 8-14	
3주	Day 15-21	
4주	Day 22-30	

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Breast Cancer, Version 7.2026(환자용 해설 2.2026·0기 1.2026 대조). NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 유방암 정보, 한국유방암학회 자료, 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 실지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **참고문헌:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터, 유방암 정보(확인일 2026.10.04). 사실 확인용 참고문헌이며, 국가암지식정보센터의 저작물을 수록하지 않았습니다. 독자 안내: 공식 암 정보와 무료 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899.
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.

- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
 - 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
 - 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.
-

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>